



## Caso clínico 1

Diagnóstico y tratamiento del niño y del adolescente

Tirzah Shiraldin Kook

Universidad de Montemorelos

Lic. Psicología Clínica

Lizzette Hernández Núñez

Montemorelos, Nuevo León

21 de agosto de 2023

## Caso clínico 1

**Nombre:** Juan Márquez Domínguez

**Motivo de consulta:** *“Juan no quiere ir a la escuela.”*

### **Antecedentes de enfermedad actual:**

Juan, un niño 8 años, lleva seis meses con bajo estado de ánimo persistente (**criterio A.1**) y disminución del interés (**criterio A.2**) en actividades que alguna vez disfrutó, como jugar con sus caritos de “Hot Wheels” y jugar fútbol con sus amigos. Informó sentirse triste y fatigado (**criterio A.1,6**). Su mamá Mencionó una disminución significativa en su funcionamiento en la escuela y dificultades para concentrarse (**criterio A.8**), lo que ha llevado bajas notas en las materias y ahora tiene sentimientos de inutilidad y culpabilidad y ya no quiere ir a la escuela, y cuando su mamá le preguntó por qué ya no quiere ir a la escuela, el respondió “soy tonto, mamá” (**criterio A,7**). Además, notó un cambio en su patrón de sueño, experimentando insomnio la mayoría de las noches y también llora bastante en las noches por no poder dormir. Su apetito también ha disminuido, lo que resulta en una notable pérdida de peso perdió 5 kilos (**criterio A.3**).

Juan experiencia cambios de humor ocasionales, pero esta es la primera vez que experiencia un período tan largo de bajo estado de ánimo persistente. Su mamá mencionó que demuestra una conducta irritable hacia ella cuando ella le da instrucciones para hacer las tareas en casa y sus tareas de la escuela. La mamá de Juan expresó su preocupación por su estado emocional y ha notado que ya no juega mucho, pero cuando juega la temática de sus juegos son de muerte.

### **Examen del estado mental:**

Paciente orientada auto y alopsiquicamente, memoria reciente conservada, discurso coherente, niega alucinaciones sensorceptivas, bajo estado anímico, insomnio e hiporexia.

**Antecedentes Personales Patológicos:** ninguno

**Antecedentes Personales Quirúrgicos:** ninguno

**Antecedentes Patológicos Familiares:** ninguno

**Hábitos:** no sustancias

**Medicación habitual:** ninguna

**Diagnóstico:** Según la presentación clínica y la historia de Juan Márquez Domínguez, cumple con los criterios para el trastorno depresivo mayor (TDM) según el DSM-5. Tiene varios síntomas característicos de TDM, que incluyen bajo estado de ánimo persistente, anhedonia (pérdida de interés o placer en las actividades), fatiga, insomnio, pérdida de peso significativa y dificultad para concentrarse, sentimientos de inutilidad. Sus síntomas han persistido durante al menos seis meses y están causando deterioro en su funcionamiento diario.

### **Diagnósticos diferenciales:**

1. **Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo:** El paciente no padece de este trastorno porque, no tiene accesos de coleras graves recurrentes que manifiestan por agresión física.
2. **Trastorno depresivo persistente (Distimia):** El paciente no padece síntomas de depresión por 2 años o más, nunca ha habido un episodio maniaco o hipomaniaco. Pero en este trastorno si presentan síntomas de depresión por 2 años o más, hay episodios maniacos y/o hipomaniacos.
3. **Trastorno depresivo inducido por una sustancia/ medicamentos:** el paciente no usa sustancias y tampoco toma ningún tipo de medicamentos, y ese trastorno está inducido por sustancias.
4. **Trastorno bipolar I:** padecen los síntomas de depresión, pero no ha tenido un episodio maniaco o hipomaniaco, ni tampoco participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas.
5. **Trastorno bipolar II:** El paciente padece síntomas de depresión, pero no habla más de lo habitual, no tiene aumento en de la actividad dirigida a un objeto, ni tampoco tiene fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad.